

ある。

b 結核性胸膜炎の鑑別

結核性胸膜炎は他の一般細菌による胸膜炎と鑑別すべき疾患である。結核性胸膜炎発症後数日は、胸水中の好中球（比率）の上昇、その後はリンパ球（比率）の上昇を認める。多くの結核性胸膜炎ではリンパ球優位であるが、特に急性期では好中球優位となりうる点は注意を要する。胸水中のアデノシンデアミナーゼ（ADA）は役立つ指標であり45～60 U/L以上の結核性胸膜炎に対する感度100%、特異度97%という報告がある。その一方で43 U/L以上であったのが78%であったとする報告もあり、ADA低値はその可能性を否定しない。結核性胸膜炎で、リンパ球優位より好中球優位な胸水のADAが高値を示したとする報告もある³⁾。

胸膜生検の組織診断や組織の培養検査は60～95%と感度の高い検査である。壊死性肉芽腫を認める疾患は結核性胸膜炎以外にサルコイドーシス、真菌感染症、関節リウマチもあることも考慮しておく。

治療と予後

抗菌薬投与と胸水のマネジメントが基本となる。

a 一般細菌が原因の場合

胸腔内への抗菌薬の移行はmetronidazoleが最も良好で、penicillin, clindamycin, vancomycin, ceftriaxone, gentamycinの順である。エンピリック治療は市中感染ではレンサ球菌、黄色ブドウ球菌、Gram陰性桿菌（腸内細菌など）および嫌気性菌を、院内感染ではそれに加えてMRSAをカバーする。嫌気性菌の関与は高く、clindamycinやmetronidazoleの投与、あるいはβ-ラクタマーゼ阻害薬配合penicillin、カルバペネム系抗菌薬投与は有効である。胸腔内感染に対しての明確な治療期間の指針はないが、数週間は投与する。

b 結核性胸膜炎の場合

治療は肺結核に準じた治療となる。結核性胸膜炎において、胸腔ドレーンの挿入の是非については大規模なランダム化比較試験は存在しない。

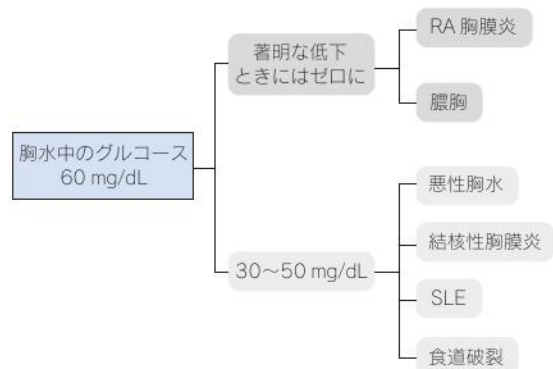


図1 胸水中グルコース濃度による鑑別

c 悪性胸水

悪性胸水患者の多くは呼吸困難を呈するが、25%は無症状である。胸痛の頻度は低いが、壁側胸膜、肋骨、肋間の構造物に影響が及ぶと生じうる。体重減少、倦怠感、食思不振は呼吸器症状に合併することが多い。

悪性胸水の治療は症状やperformance status (PS)、腫瘍のタイプ、化学療法への反応性、胸水排出後の肺の再膨張の程度などにより決定される。悪性胸水は胸水の完全ドレナージと胸膜癒着術により最もよくコントロールされるが、経過観察、胸水穿刺、肋間からのドレナージチューブの挿入と胸膜癒着術、胸腔鏡検査を利用した胸膜癒着術などの選択肢がある⁴⁾。胸水中のCEA上昇は悪性胸水を疑う根拠となるが⁶⁾、まれに膿胸で気道上皮細胞のCEA産生増加に伴う影響を受けることに留意する。

文 献

- 1) Light RW : N Engl J Med **346** : 1971, 2002
- 2) Colice GL, et al : Chest **118** : 1158, 2000
- 3) Bielsa S, et al : Int J Tuberc Lung Dis **17** : 85, 2013
- 4) British Thoracic Society : Thorax **65** : ii32, 2010
- 5) British Thoracic Society : Thorax **65** : ii 41, 2010
- 6) Saraya T, et al : Medicine (Baltimore) **98** : e15003, 2019